全　域　融　合　·　智　慧　無　界

跨越照護斷層：建構醫療、長照與安寧緩和的在地安居網絡

2026 國際整合照顧與在地安居韌性網絡研討會 | 臺北榮總家庭醫學部 林明慧主任

臺北市立聯合醫院仁愛院區6F大禮堂 | 20260821 (W5) 15:20-15:40

CC BY NC SA

常見高齡個案生命最後的一哩路

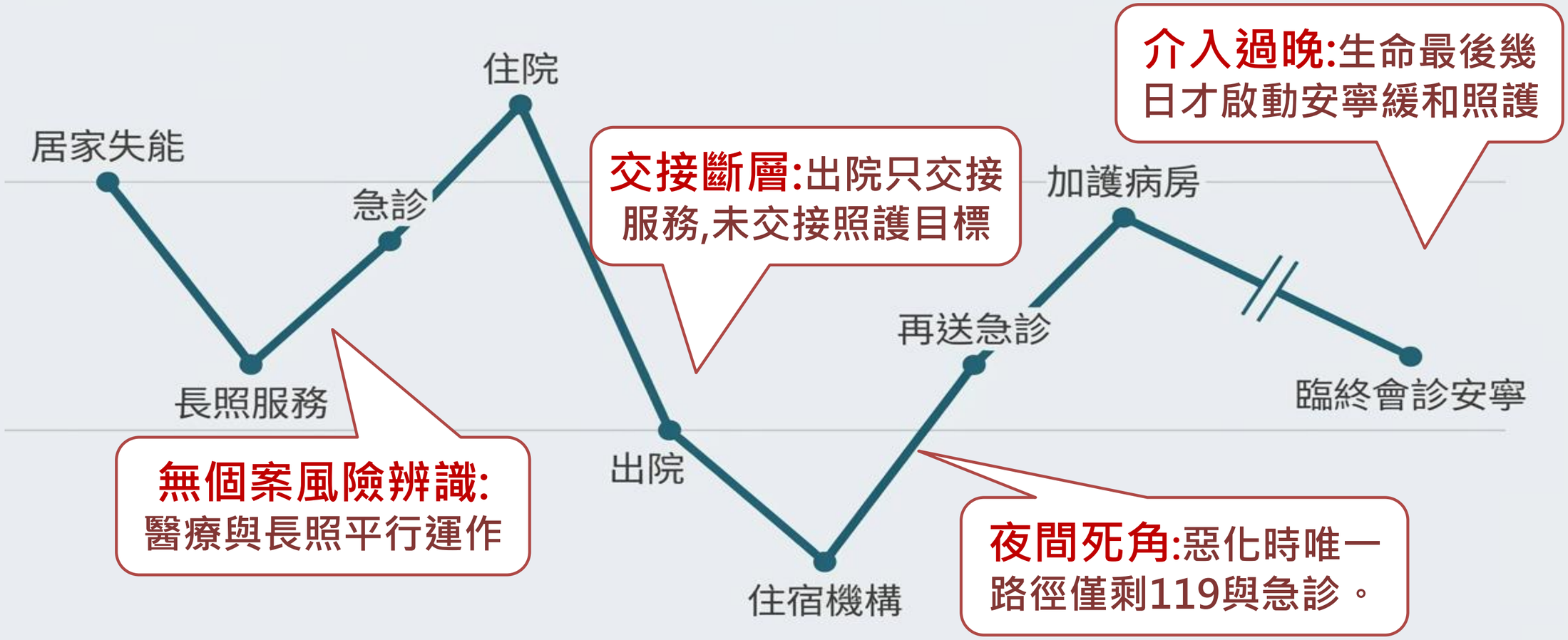


88歲女性，失智超過8年，有多重慢病
最近半年開始倚賴鼻胃管灌食

- **HF** 心衰竭 (Heart Failure)
- **CKD** 慢性腎臟病 (CKD)
- **D** 失智症 (Dementia)
- **AP** 反覆吸入性肺炎 (Recurrent Aspiration Pneumonia)

Ming-Hwai

「每一站都有專業人員，卻沒有人對整段旅程負責。」



頻繁轉換的「轉運站」模式

系統中的五個關鍵「照護斷層」

1 疾病 vs. 功能：
醫院處理疾病，長照處理失能，
多病共存者被撕裂。

2 出院 vs. 返家：
出院摘要完成，
≠ 家庭具備照護能力。

3 白天 vs. 夜間：
日間有居服，夜間急性
症狀只能進急診。

4 醫院 vs. 機構：
住民反覆送醫，醫院無平日
軌跡，機構無處置計畫。

5 長照 vs. 安寧：
長照維持生活，卻未同步
辨識生命末期與善終需求。



居家 → 醫院 → 社區 → 長照機構 → 安寧照護

生命歷程

定義照護斷層：當個案跨越場域、組織或支付制度時，
臨床資訊、照護責任、決策目標與即時支援，至少有一項發生中斷。

照護斷層的代價：高度依賴急診與住院

末期病人不是沒有接受照護，而是照護集中在錯誤的場域。

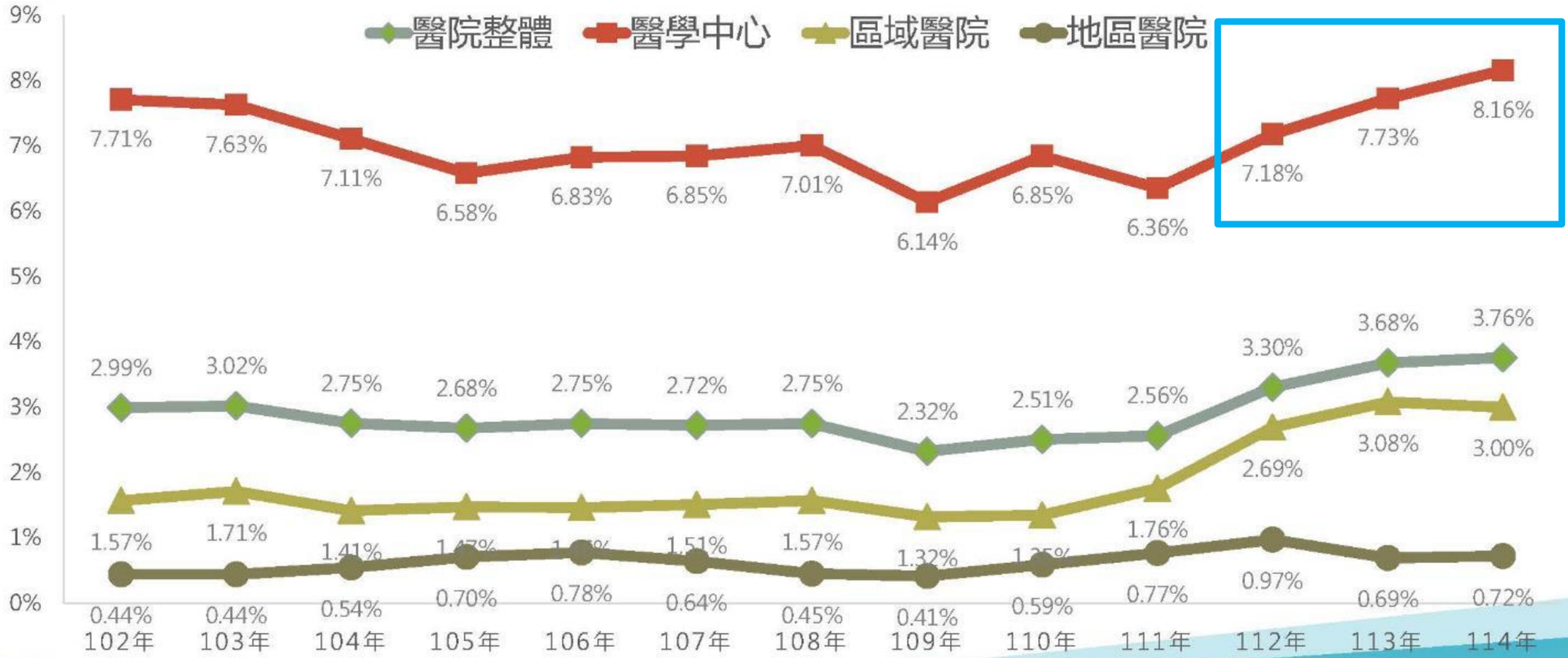
80.3%

死亡前一年曾有急診紀錄。缺乏社區替代照護能力是反覆送醫的結構性原因。

急診壅塞：急診滯留超過24小時比率

過程面

急診留滯情形雖呈上升趨勢，本署已分別於114/8/1實施門診靜脈抗生素治療獎勵方案、114/11/2推行週日及國定假日輕急症中心試辦計畫，查115年Q1各層級均略有下降，將持續滾動檢討精進



急診滯留 >2日的82位病人，反映了高齡、多病、失能、末期交疊



56.1%

46人

至少同時具有2項特質

29.3%

24人

至少同時具有3項特質

這表示急診壅塞不只是「加床」問題，而是「照護去向設計」問題。

急診壅塞的主要原因，不只是『床不夠』

功能性床位不足

31人屬特殊床位障礙型

隔離/MDR、透析、呼吸支持等需求，
使『有床』不等於『有適合的床』。

急性醫療與長照之間缺少橋樑

23人值得啟動HAH評估

其中6人可優先直接評估；
HAH可承接『急性但穩定』病人。

安寧介入過晚

癌症／血液腫瘤38人；DNR 12人

其中11人歸入安寧需求型，
提示應更早進行Goals of Care與安寧轉銜。

高齡失能整合收治不足

高齡失能／家醫老醫型9人

另有大量病人合併失智、臥床、神經失能，
需整合性內科與出院轉銜。

核心問題：病人複雜度 × 床位功能錯配 × 替代照護路徑不足

醫療、長照、安寧斷層的交會點

急診壅塞:反映社區、長照與安寧整合不足

醫療斷層

- 仍以『疾病 → 專科 → 病床』思考
- 忽略功能狀態、照護目標與出院承接
- 結果：不是每位病人都適合走傳統住院路徑

長照斷層

- 高齡失能者發生感染、脫水、肺炎等急性事件
- 回家太早，住院又未必都需要
- 中間缺少『急性但穩定』的承接層

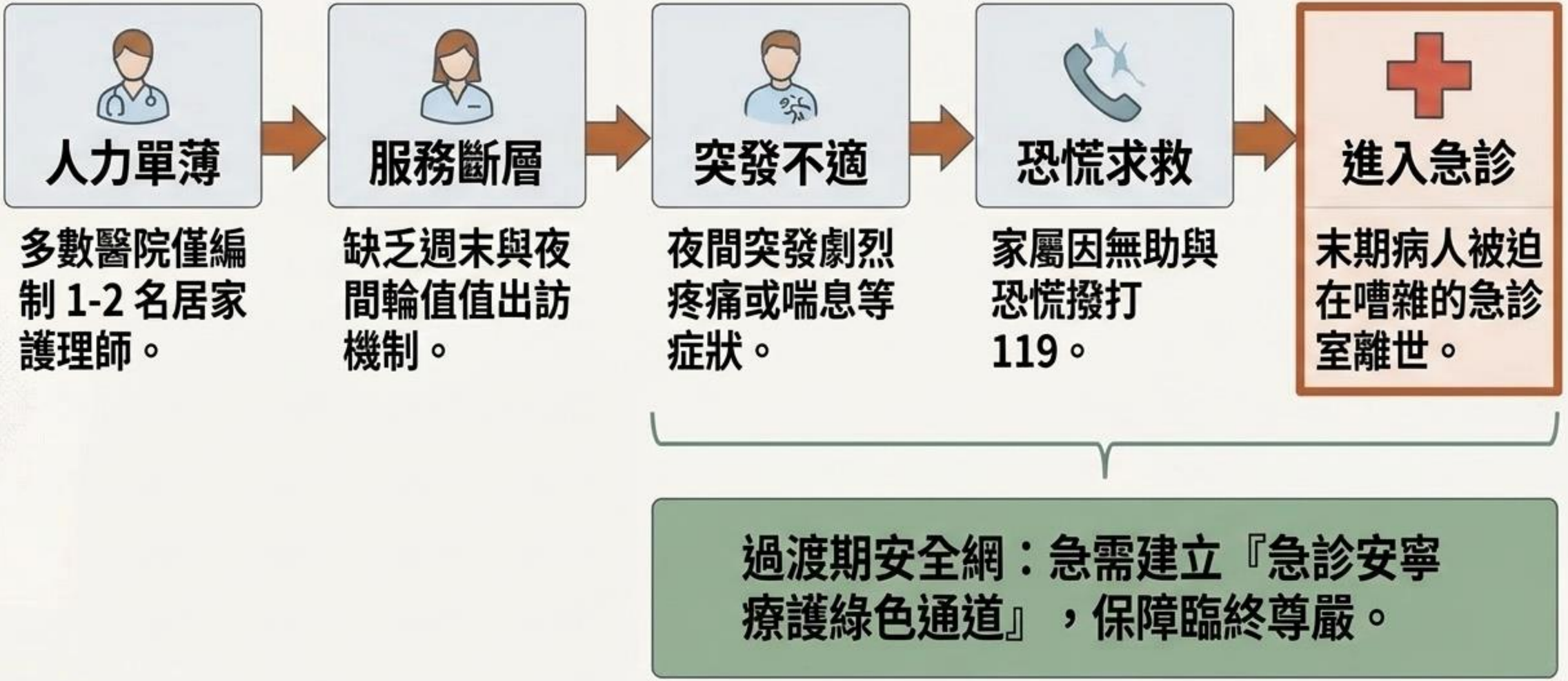
安寧緩和斷層

- 晚期癌症、DNR、反覆感染與器官衰竭
- 照護目標常在急診才被迫討論
- 結果:反覆進出急診與延長待床

急診端看見的是三套系統的交會

慢性病／癌症／失能 → 急性惡化 → 急診；若只有「回家」與「住院」兩個傾出口，就會在急診累積成壅塞。

系統性困境：為何善終之路走向急診？



政策重構：從「病床配置」轉向「區域網絡」

過去（舊思維）

- 規劃單位：以「醫院層級」配置資源
- 介入時機：單向的末期出院轉介
- KPI指標：增設了多少「安寧病床」與死亡地點是否在家

未來（新典範）

- 規劃單位：以「醫療生活圈」配置照護責任
- 介入時機：提早辨識與長照／醫療共同介入
- KPI指標：是否具備 24 小時雙向緊急應變與合理交通距離內的團隊覆蓋

表5-15　健保署所擬114年度方案（草案）修正重點

策略	管控項目	113 年 目標值	114 年 目標值	調整情形
尊重醫療自主保障善終權益	~~15. 死亡前安寧利用率~~	≧ 35.6%		刪除
	~~16. 呼吸器依賴病人安寧利用率~~	≧ 74.8%		刪除
	14. 居家安寧照護對象在宅善終比率較前 1 年成長（114 年新增）		>1%	新增

表5-12　113年監理指標監測結果重點摘要表

指標	近 3 年監測結果 （○：進步　△：穩定狀況　×：退步）
1.1 急性病床平均住院天數（整體及各層級）	○ 整體、醫學中心及區域醫院呈下降趨勢 •地區醫院急性病床平均住院天數為三層級最高
1.2 急診病人留置急診室超過 24 小時比率（整體及各層級）	× 整體及醫學中心、區域醫院呈上升趨勢 •醫學中心、區域醫院檢傷分類第 1、2 級留置比率逐年上升
1.3 癌末病人接受安寧療護比率及生前 6 個月每人申報醫療費用點數	○ 呈微幅上升趨勢

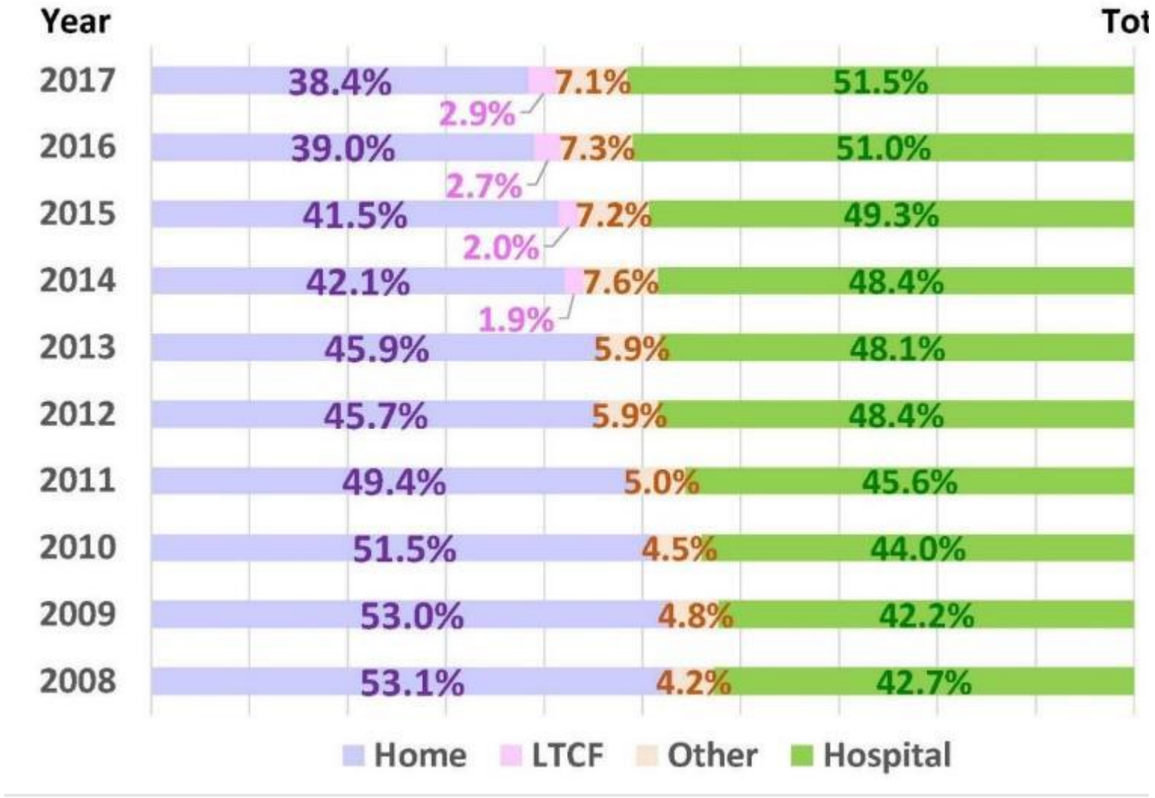


Ming-Hwai

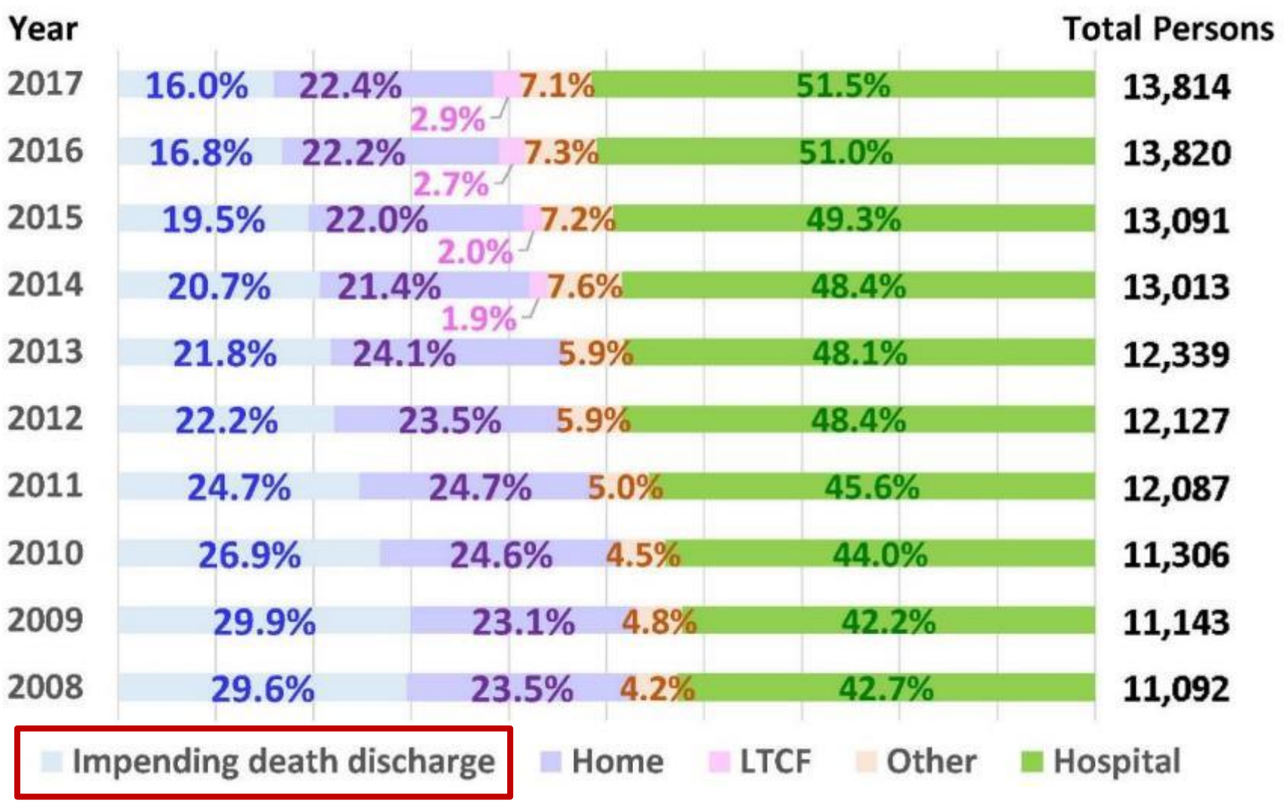
迷思與現實：「在家死亡」不等於「在家被照顧」



2008-2017臺灣自然死亡人數和地點百分比的變化



2008-2017臺灣自然死亡人數和地點百分比的變化
(增加瀕死返家類別後)



以上兩圖乃使用國民健康保險署從200萬抽樣檔 LGTD 2005 進行估計
(乘以11.3可獲得接近真實數字。LTCF：長照機構)

Ming-Hwai

被低估的痛點：無奈的臨終返家 (IDD)

The IDD Journey



社區居家支持匱乏

↓

臨終前緊急送急診

↓

高醫療費用 / 高住院天數

↓

匆忙辦理出院，無奈臨終返家 (IDD)



從「轉介成功」走向「安居與善終成功」

從「服務量」轉向「結果」：

減少最後30天急診，提升偏好地點死亡比例。

從「機構責任」轉向「區域共同責任」：

不再問這是誰的病人，而是問區域如何共同承擔。

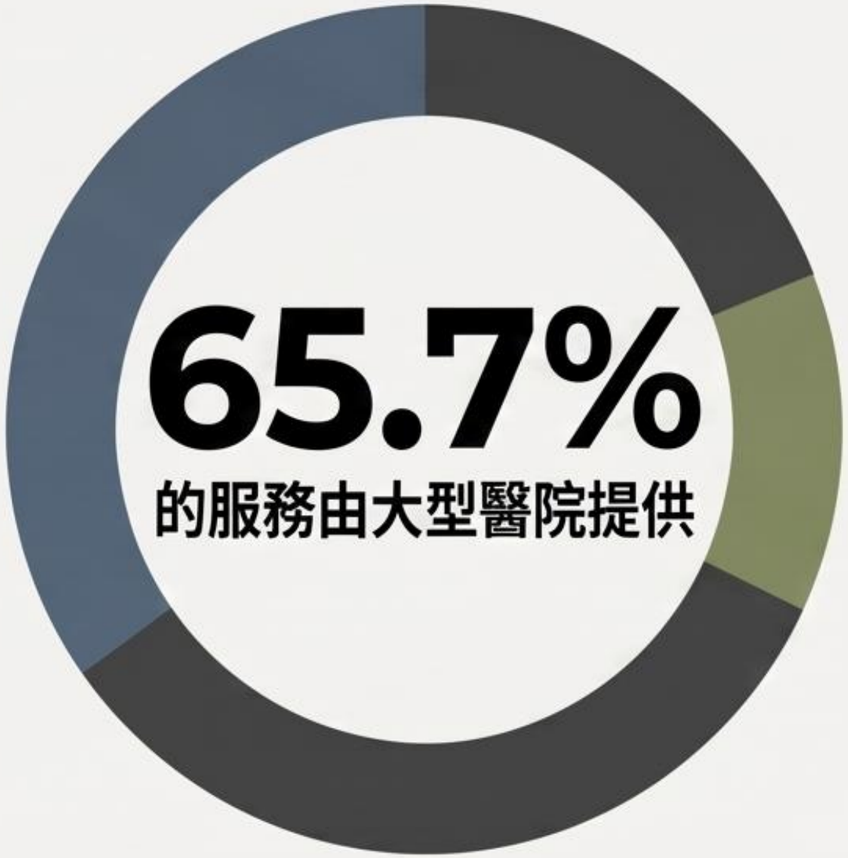
從「在地老化」走向「在地安居」：

平時能生活，惡化有支援，失能不遺棄，臨終不被迫離開。

政策倡議：以「醫療生活圈」配置照護責任

不能再以單一醫院層級配置資源，必須建構區域責任網

甲類安寧居家服務：高度集中化



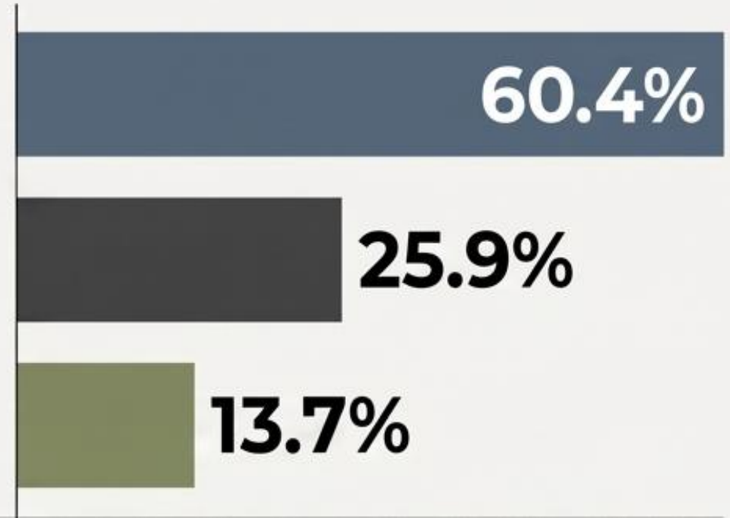
甲類服務資源高度依賴醫學中心及區域醫院，地區醫療機構量能相對薄弱。



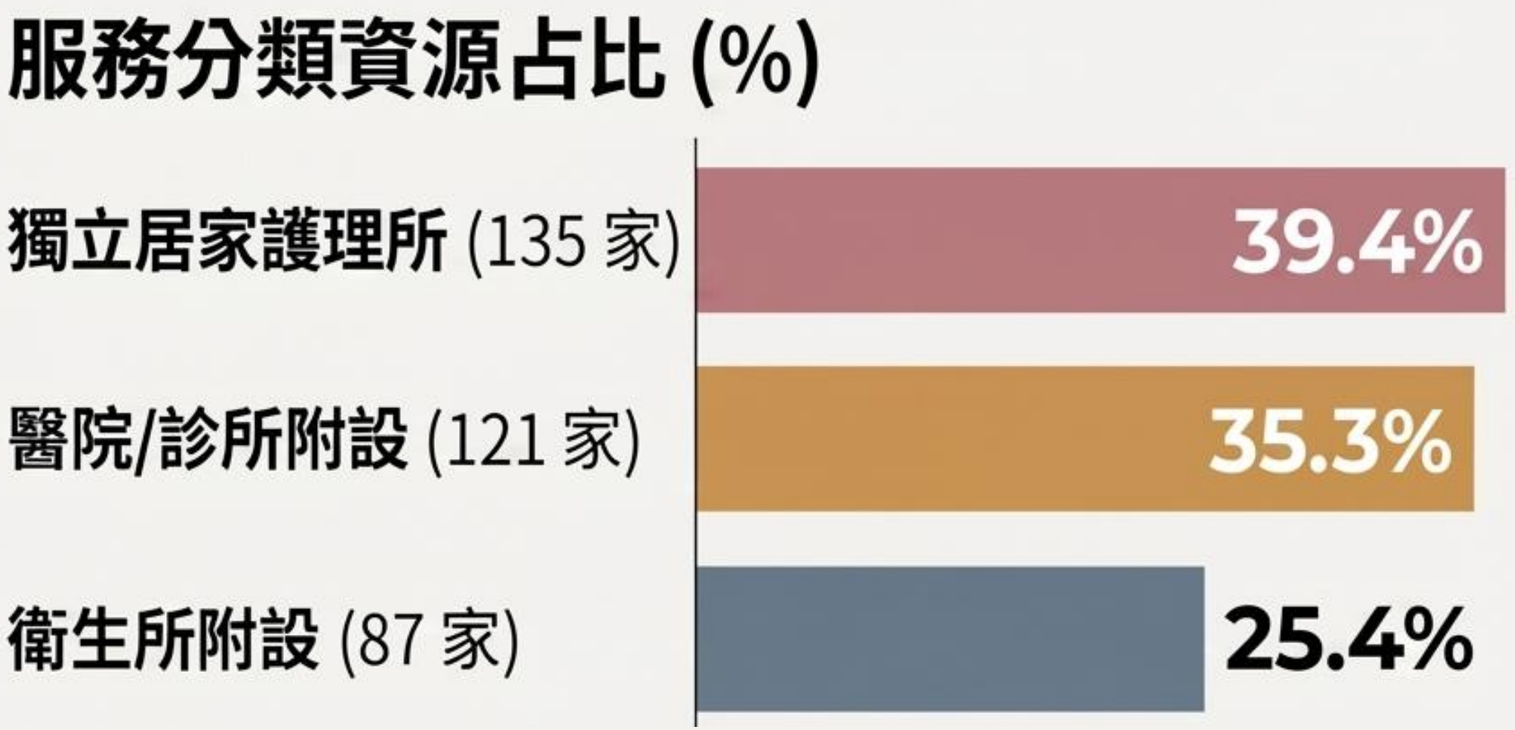
全國僅 139 個實際運作團隊

扣除重複列計後，實際能提供完整甲類居家安寧團隊服務的機構數量稀少

機構類別資源占比 (%)



乙類社區安寧：量能分散與結構限制



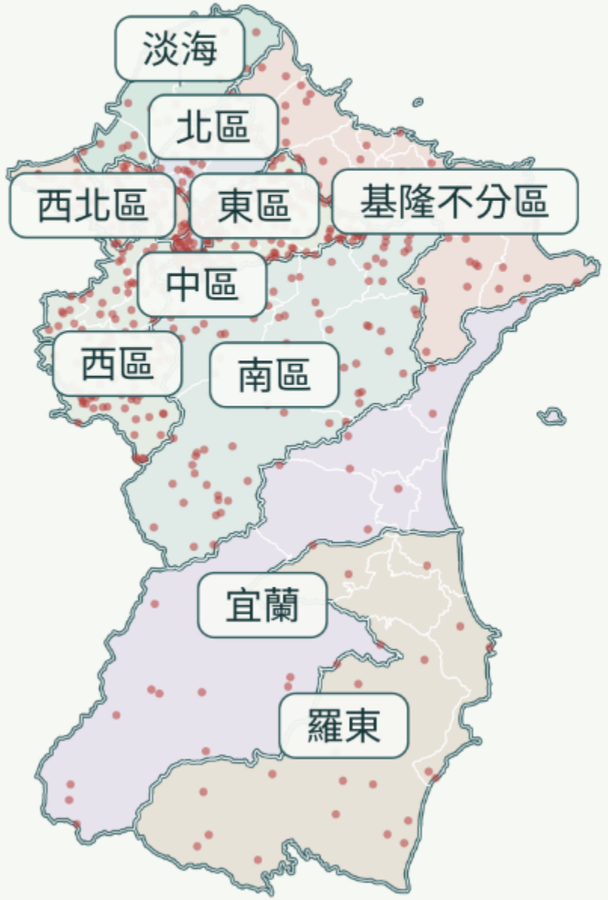
Ming-Hwai

臺北區醫療次區域地圖

臺北區 10 個醫療次區域：死亡需求與安寧資源分布

114年死亡 57,158 人｜安寧病房 28 家｜安寧居家團隊 36 隊

114年底人口數：7,446,444



次區	死亡	病房	居家
西區	10,904	4	3
東區	9,526	3	4
南區	8,007	4	7
中區	7,379	3	5
西北區	6,195	1	4
基隆不分區	4,711	2	2
北區	4,053	5	4
羅東	2,172	3	4
淡海	2,148	1	1
宜蘭	2,063	2	2
合計	57,158	28	36

• 1紅點＝100人死亡（114年）

紅點於次區內隨機配置，呈現相對密度，非個案地址。

病房＝院所數；居家＝團隊數

北區醫療次區域地圖

北區 9 個醫療次區域：死亡需求與安寧資源分布

114年死亡 28,957 人｜安寧病房 7 家｜安寧居家團隊 15 隊

114年底人口數：3,939,253 人



次區	死亡	病房	居家
中壢	5,857	0	1
桃園	5,238	3	5
平德	5,071	0	1
新竹	2,888	1	3
竹北	2,290	0	2
苗栗	2,286	1	1
竹東	2,031	1	1
中港	1,901	1	1
海線	1,395	0	0
合計	28,957	7	15

- 1紅點＝100人死亡（114年）

紅點於次區內隨機配置，呈現相對密度，非個案地址。

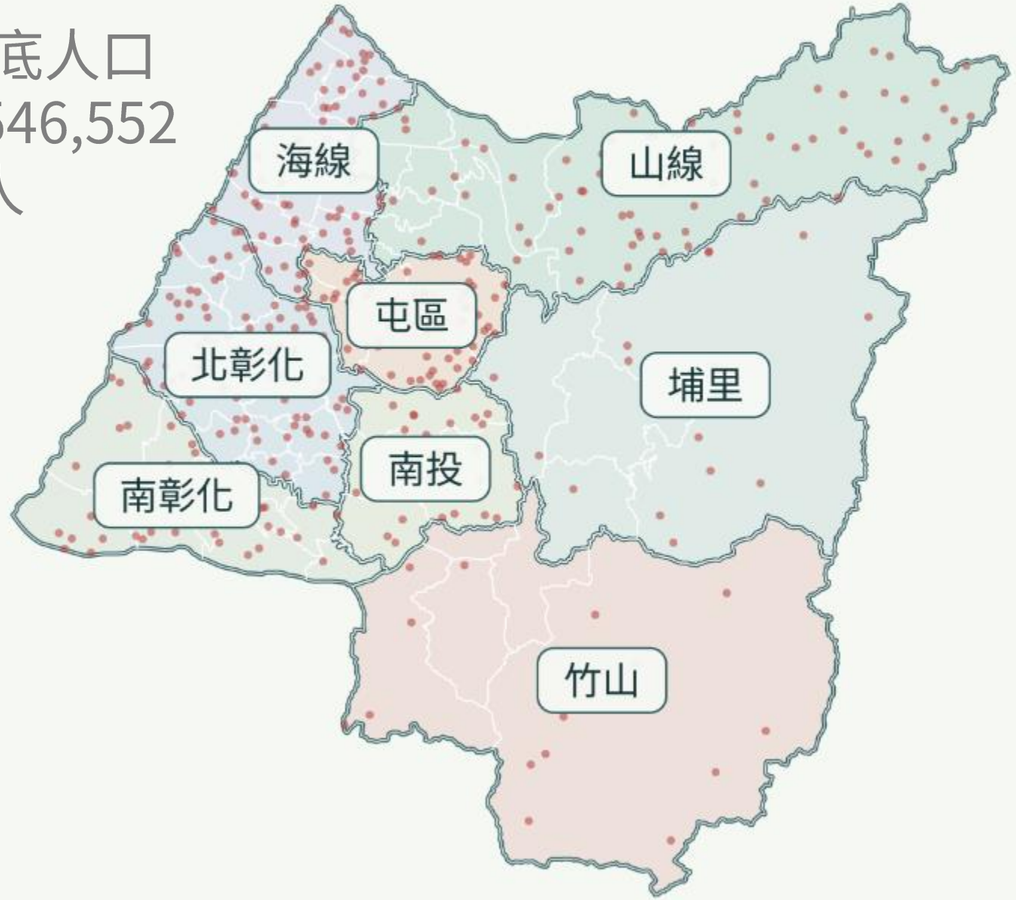
病房＝院所數；居家＝團隊數

中區醫療次區域地圖

中區 8 個醫療次區域：死亡需求與安寧資源分布

114年死亡 37,919 人｜安寧病房 14 家｜安寧居家團隊 29 隊

114年底人口數：4,546,552人



次區	死亡	病房	居家
北彰化	8,474	3	3
山線	7,336	3	5
海線	6,742	4	6
屯區	6,603	1	11
南彰化	3,316	0	0
南投	2,453	1	1
埔里	1,535	2	2
竹山	1,460	0	1
合計	37,919	14	29

- 1紅點＝100人死亡（114年）

紅點於次區內隨機配置，呈現相對密度，非個案地址。

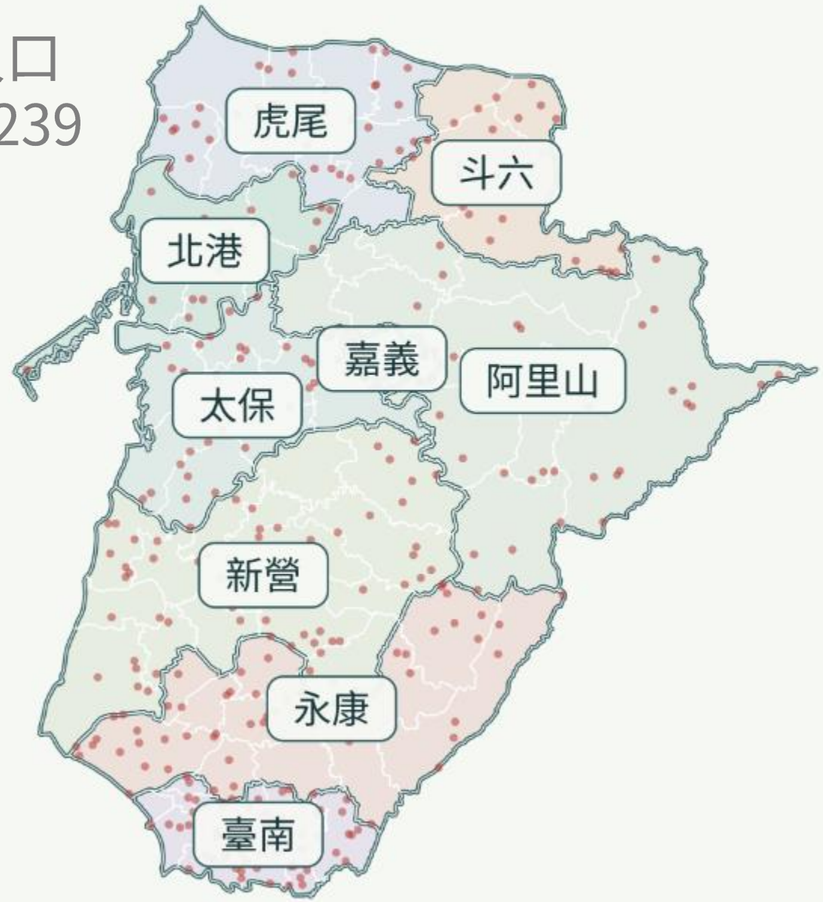
病房＝院所數；居家＝團隊數

南區醫療次區域地圖

南區 9 個醫療次區域：死亡需求與安寧資源分布

114年死亡 33,899 人｜安寧病房 15 家｜安寧居家團隊 23 隊

114年底人口數：3,238,239 人



次區	死亡	病房	居家
臺南	6,451	3	5
永康	5,611	3	4
新營	5,573	1	3
虎尾	3,479	1	2
阿里山	3,240	1	2
太保	3,013	2	1
斗六	2,361	0	1
嘉義	2,230	4	5
北港	1,941	0	0
合計	33,899	15	23

- 1紅點＝100人死亡（114年）

紅點於次區內隨機配置，呈現相對密度，非個案地址。

病房＝院所數；居家＝團隊數

高屏區醫療次區域地圖

高屏區 8 個醫療次區域：死亡需求與安寧資源分布

114年死亡 35,235 人｜安寧病房 14 家｜安寧居家團隊 24 隊

114年底人口數：3,607,517 人



次區	死亡	病房	居家
高雄	14,224	6	10
岡山	8,902	2	5
屏東	5,377	4	4
東港	2,593	0	1
旗山	1,926	1	1
澎湖	1,010	1	3
恆春	684	0	0
枋寮	519	0	0
合計	35,235	14	24

- 1紅點＝100人死亡（114年）

紅點於次區內隨機配置，呈現相對密度，非個案地址。

病房＝院所數；居家＝團隊數

東區醫療次區域地圖

東區 7 個醫療次區域：死亡需求與安寧資源分布

114年死亡 6,088 人｜安寧病房 7 家｜安寧居家團隊 11 隊

114年底人口數：521,127人



次區	死亡	病房	居家
花蓮	2,018	3	4
臺東	1,048	3	4
玉里	805	1	1
鳳林	780	0	2
關山	666	0	0
成功	463	0	0
大武	308	0	0
合計	6,088	7	11

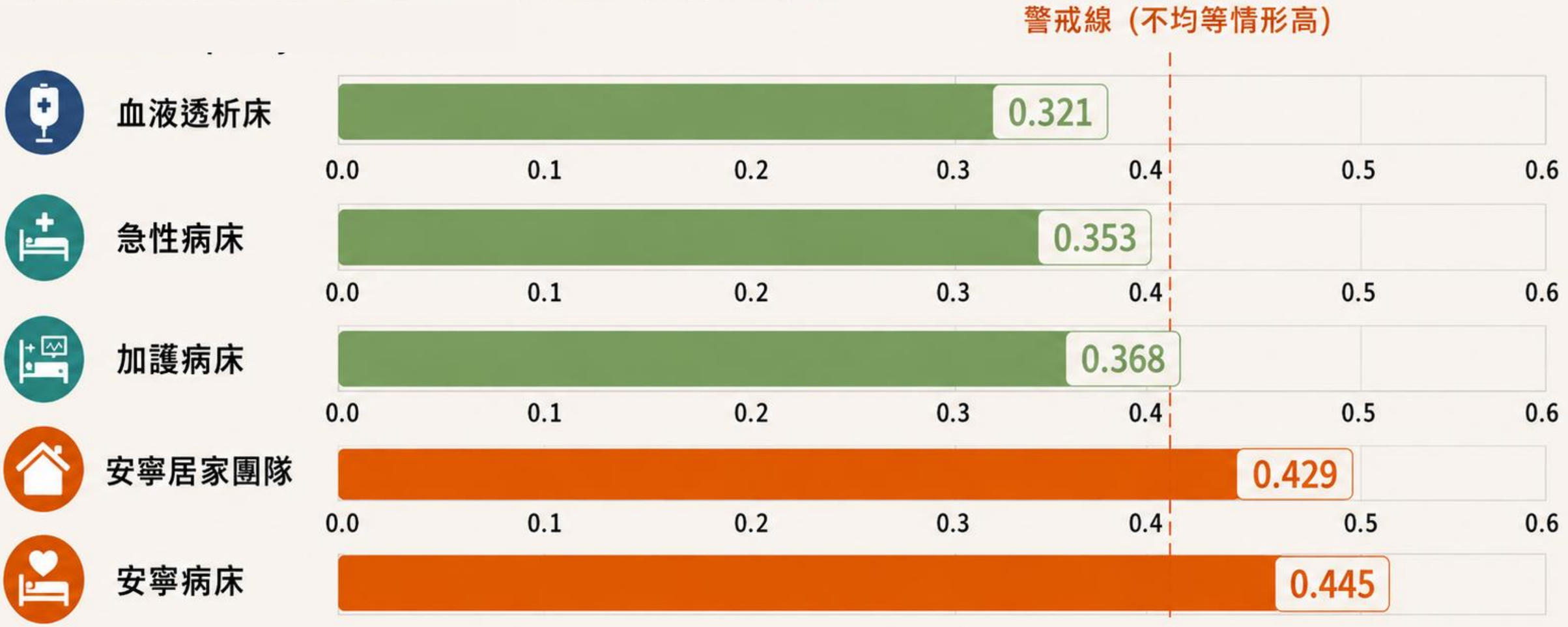
- 1紅點＝100人死亡（114年）

紅點於次區內隨機配置，呈現相對密度，非個案地址。

病房＝院所數；居家＝團隊數

資源分配的不平權：吉尼係數揭示的真相

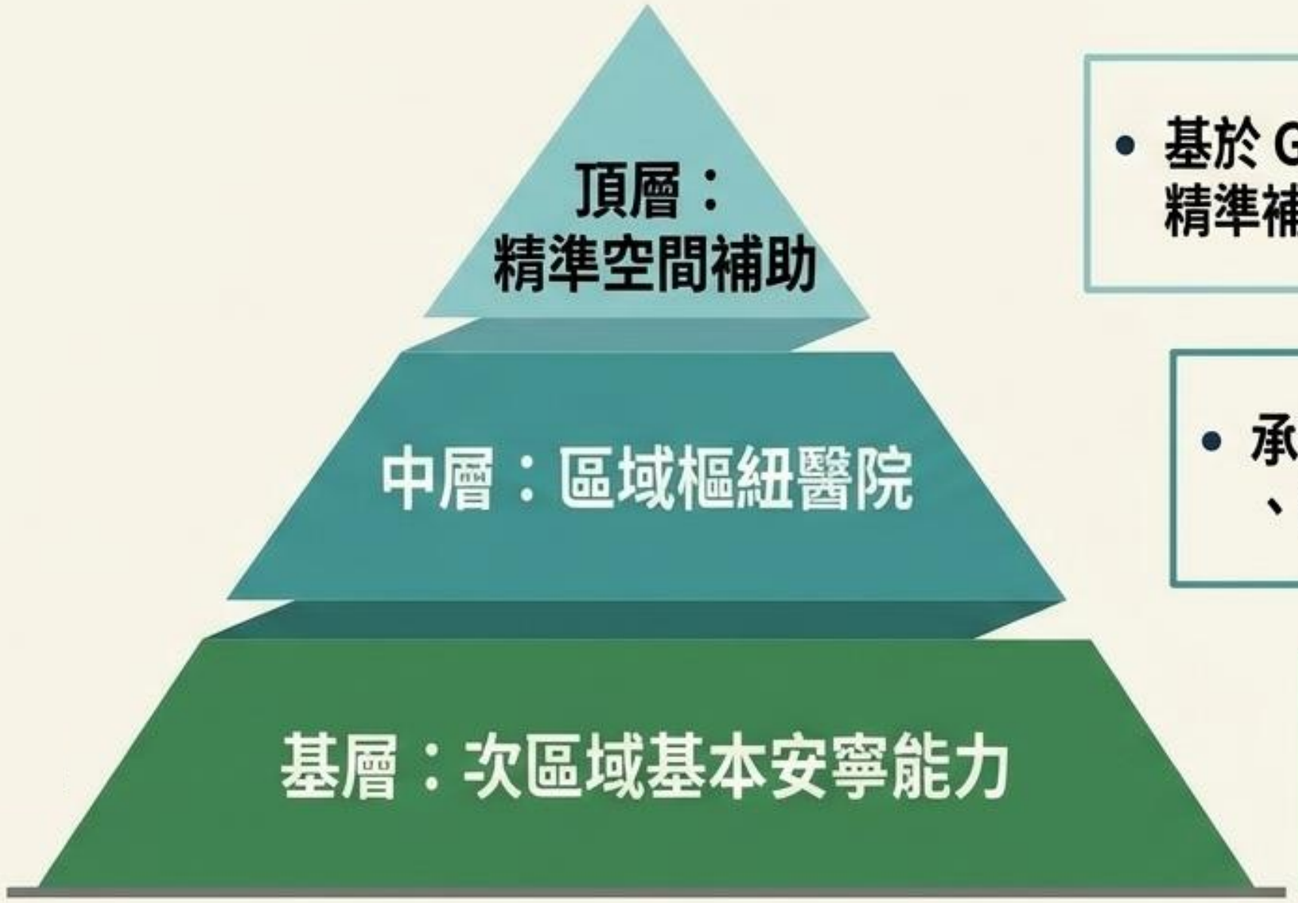
各類安寧與急性資源分配差距大，影響在地安居的公平性



安寧資源分配的不均程度仍高於一般急性與透析醫療資源的城鄉差距，
影響公平可近的在地安居與善終。

排序	二級醫療區域	次醫療區域	行政區範圍	114年底人口 (23,299,132)	安寧居家團隊需求	安寧居家團隊數	差距
1	臺北	西區	板橋區、新莊區、樹林區、土城區、三峽	1,595,636	16.0	3	-13.0
2	臺北	東區	大安區、信義區、松山區、內湖區、南港	1,263,048	12.6	4	-8.6
3	桃園	中壢	大園區、觀音區、中壢區、新屋區、楊梅區	839,012	8.4	1	-7.4
4	彰化	北彰化	和美鎮、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、彰化	940,755	9.4	3	-6.4
5	桃園	平德	八德區、平鎮區、大溪區、龍潭區、復興區	678,723	6.8	1	-5.8
6	高雄	高雄	三民區、小港區、前金區、前鎮區、苓雅	1,560,183	15.6	10	-5.6
7	高雄	岡山	楠梓區、左營區、岡山區、橋頭區、燕巢	1,040,159	10.4	5	-5.4
8	臺北	西北區	三重區、蘆洲區、五股區、林口區、泰山區	890,410	8.9	4	-4.9
9	臺中	山線	北屯區、北區、豐原區、石岡區、新社區、	941,033	9.4	5	-4.4
10	臺中	海線	西屯區、西區、清水區、沙鹿區、梧棲區、	959,739	9.6	6	-3.6
11	臺北	中區	中正區、中山區、萬華區、大同區、永和區	853,090	8.5	5	-3.5
12	桃園	桃園	蘆竹區、桃園區、龜山區	837,371	8.4	5	-3.4
13	臺北	南區	文山區、新店區、中和區、烏來區、深坑	1,011,315	10.1	7	-3.1
14	彰化	南彰化	芳苑鄉、二林鎮、埤頭鄉、竹塘鄉、大城	269,451	2.7	0	-2.7
15	臺南	永康	安南區、楠西區、玉井區、左鎮區、南化	668,595	6.7	4	-2.7
16	臺南	臺南	東區、中西區、北區、安平區、南區、仁德	756,976	7.6	5	-2.6
17	基隆	不分區	基隆市、金山區、萬里區、瑞芳區、雙溪	453,280	4.5	2	-2.5
18	新竹	竹北	竹北市、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮	399,336	4.0	2	-2.0
19	臺北	淡海	石門區、三芝區、淡水區、八里區	283,554	2.8	1	-1.8
20	新竹	新竹	新竹市	455,740	4.6	3	-1.6

實現在地安居的三層次政策架構



- 基於 GIS 空間分析（如5km/10km服務半徑），精準補助未被覆蓋地區的社區醫院成立居家團隊。

- 承擔複雜症狀控制、住院安寧、跨院共同照護、遠距會診與基層教育訓練。

- 每個醫療次區域「必須」具備基本居家團隊、24 小時諮詢、急性症狀處理轉診機制與長照支援。

政府不應只計算「縣市總量」，而應透過三層架構確保每個次區域皆具備基本防護網。

*0604六區整理 — QGIS

專案(J) 編輯(E) 檢視(V) 圖層(L) 設定(S) 外掛程式(P) 向量(o) 影像(R) 資料庫(D) 網路(Web) 網孔(M) 地理運算(c) 說明(H) Raster Vector

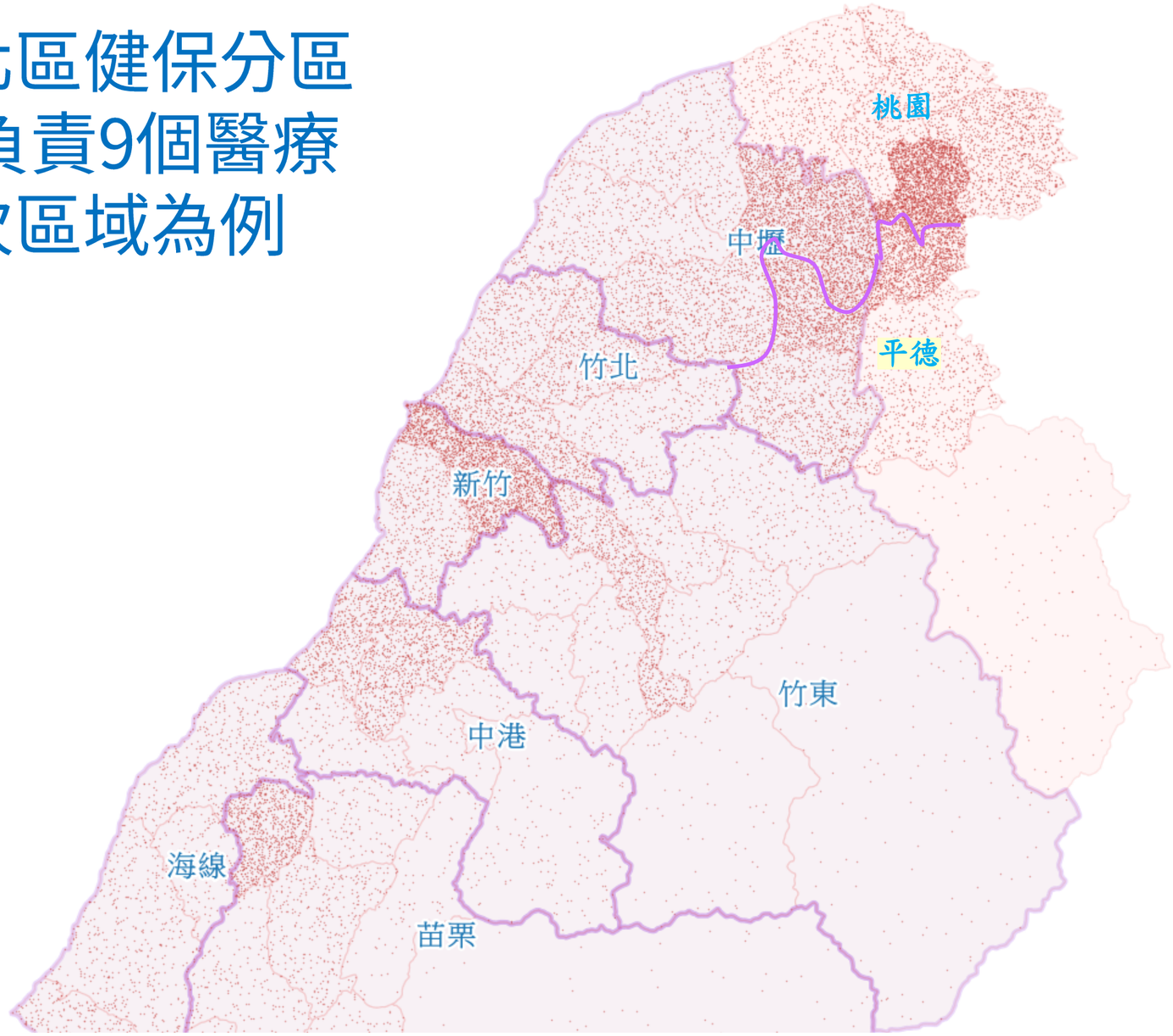
圖層

- group1
- group2
  - 1N
  - NEW_NORTH
  - DOT_死亡密度_NORTH
  - DOT_NORTH
  - 健保北區
  - 32VHCA_North14
  - HW_NAME
  - HW_N
  - 32VHCA_NORTH_NAME
  - 10KM_N
  - 5KM_N
- group3
- group4
- group5
- group6
- NEW_AREA
- NEW_ER_AREA
- ER_A
- ER_B
- ER_C
- 2VHW_85
- HW_NORTH
- DOT_死亡密度368
- DOT底圖
- 健保六大分區原圖
- Taiwan e-Map(new)
- 1死亡密度368
- 1死亡密度50
- DOT
- VV0517_368
- 1

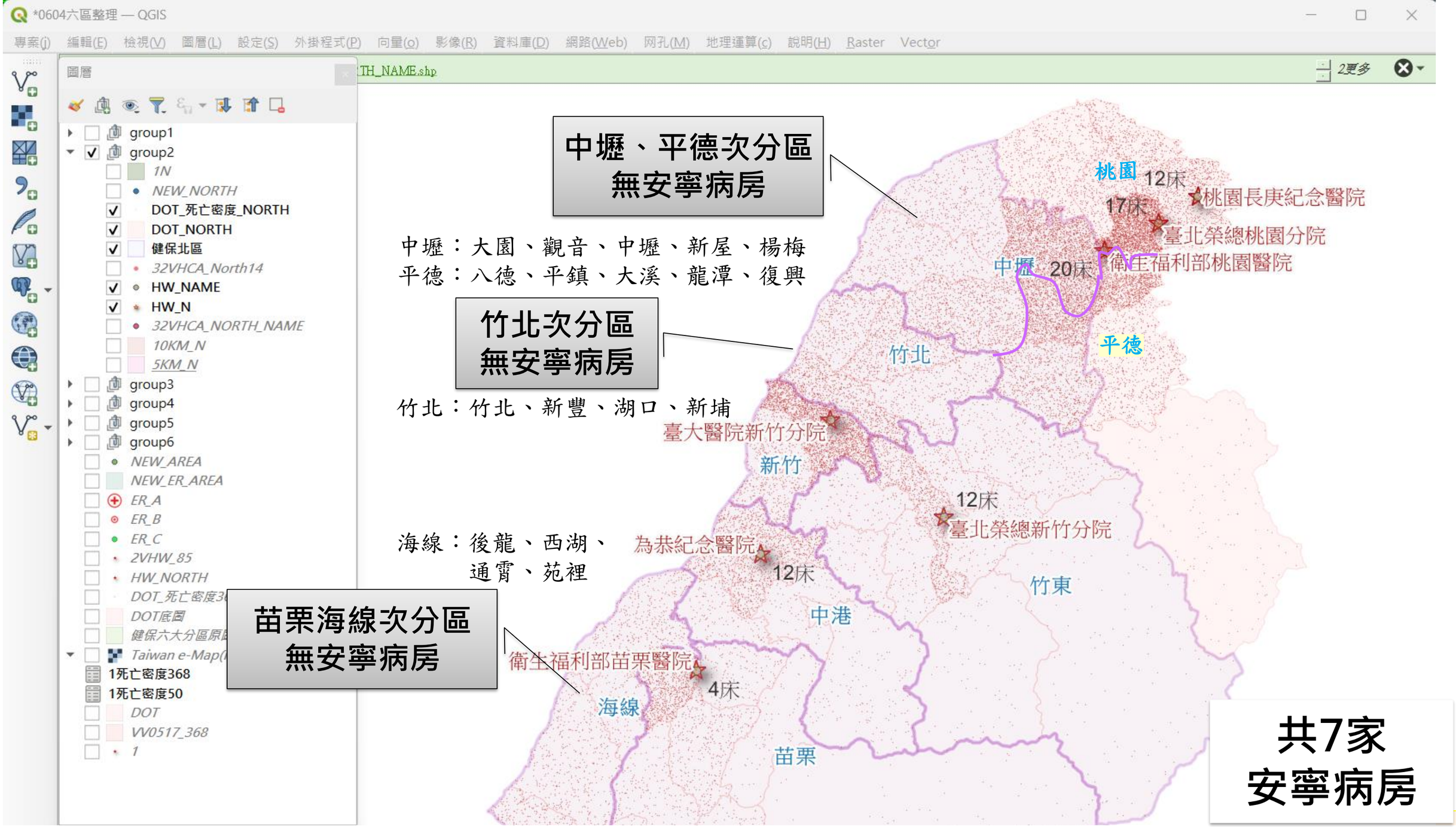
TH_NAME.shp

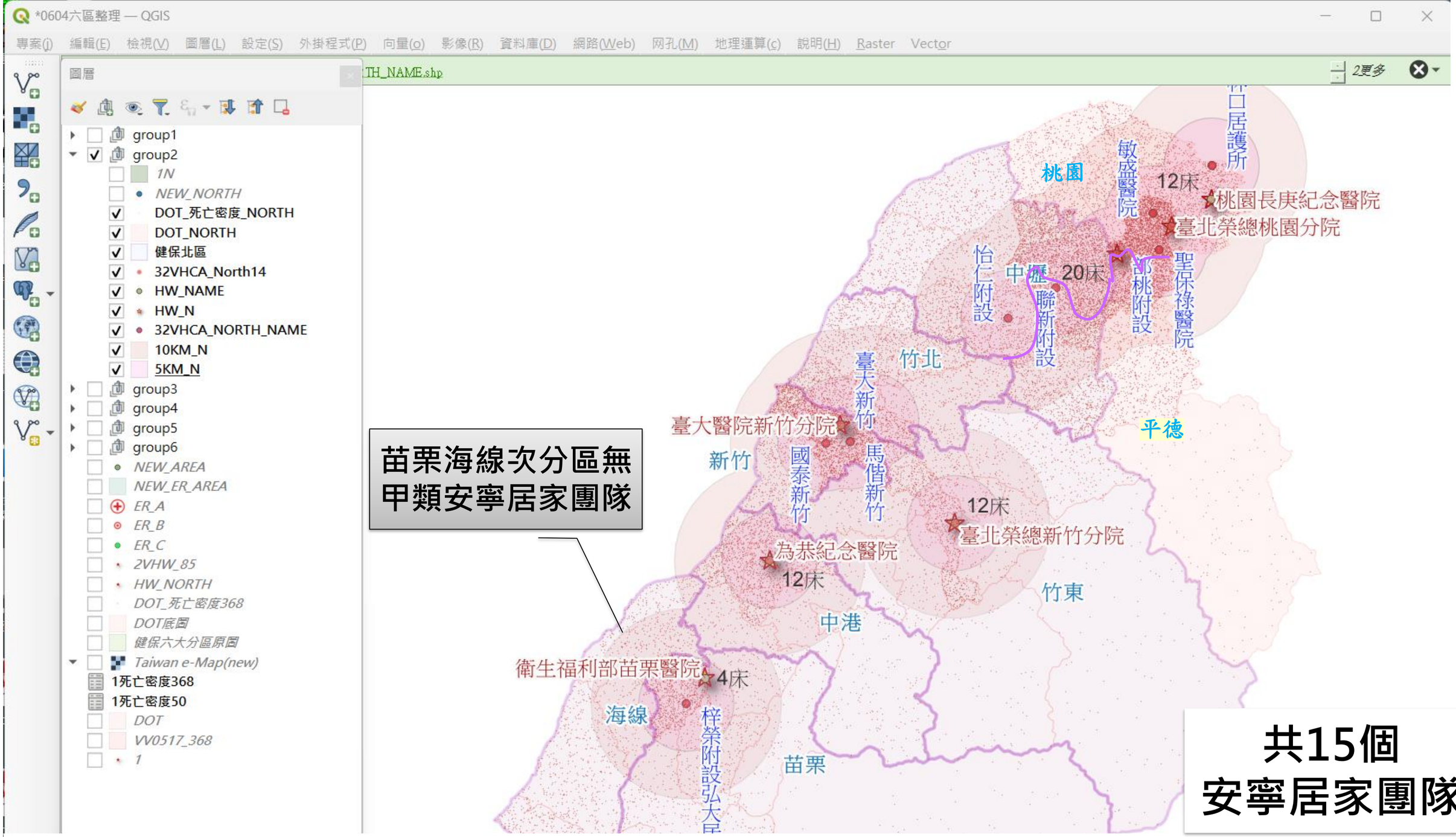
2更多

以北區健保分區所負責9個醫療次區域為例



北區安寧資源分布


*0604六區整理 — QGIS
專案(J) 編輯(E) 檢視(V) 圖層(L) 設定(S) 外掛程式(P) 向量(o) 影像(R) 資料庫(D) 網路(Web) 网孔(M) 地理運算(c) 說明(H) Raster Vector
圖層
group1
group2
1N
NEW_NORTH
DOT_死亡密度_NORTH
DOT_NORTH
健保北區
32VHCA_North14
HW_NAME
HW_N
32VHCA_NORTH_NAME
10KM_N
5KM_N
group3
group4
group5
group6
NEW_AREA
NEW_ER_AREA
ER_A
ER_B
ER_C
2VHW_85
HW_NORTH
DOT底圖
Taiwan e-Map
1死亡密度368
1死亡密度50
DOT
VV0517_368
1
中壢、平德次分區
無安寧病房
中壢：大園、觀音、中壢、新屋、楊梅
平德：八德、平鎮、大溪、龍潭、復興
竹北次分區
無安寧病房
竹北：竹北、新豐、湖口、新埔
海線：後龍、西湖、
通霄、苑裡
苗栗海線次分區
無安寧病房
桃園 12床
桃園長庚紀念醫院
17床
臺北榮總桃園分院
衛生福利部桃園醫院
中壢 20床
平德
竹北
臺大醫院新竹分院
新竹
12床
臺北榮總新竹分院
為恭紀念醫院
12床
竹東
中港
衛生福利部苗栗醫院
4床
海線
苗栗
共7家
安寧病房


*0604六區整理 — QGIS
專案(J) 編輯(E) 檢視(V) 圖層(L) 設定(S) 外掛程式(P) 向量(o) 影像(R) 資料庫(D) 網路(Web) 网孔(M) 地理運算(c) 說明(H) Raster Vector
圖層
group1
group2
1N
NEW_NORTH
DOT_死亡密度_NORTH
DOT_NORTH
健保北區
32VHCA_North14
HW_NAME
HW_N
32VHCA_NORTH_NAME
10KM_N
5KM_N
group3
group4
group5
group6
NEW_AREA
NEW_ER_AREA
ER_A
ER_B
ER_C
2VHW_85
HW_NORTH
DOT_死亡密度368
DOT底圖
健保六大分區原圖
Taiwan e-Map(new)
1死亡密度368
1死亡密度50
DOT
VV0517_368
1
苗栗海線次分區無甲類安寧居家團隊
桃園
敏盛醫院
12床
桃園長庚紀念醫院
臺北榮總桃園分院
怡仁附設
中壢
20床
聯新附設
部桃附設
聖保祿醫院
竹北
臺大新竹
臺大醫院新竹分院
新竹
國泰新竹
馬偕新竹
平德
12床
臺北榮總新竹分院
為恭紀念醫院
12床
竹東
中港
衛生福利部苗栗醫院
4床
海線
梓榮附設弘大
苗栗
共15個安寧居家團隊


*0604六區整理 — QGIS
專案(J) 編輯(E) 檢視(V) 圖層(L) 設定(S) 外掛程式(P) 向量(o) 影像(R) 資料庫(D) 網路(Web) 網孔(M) 地理運算(c) 說明(H) Raster Vector
圖層
group1
group2
1N
NEW_NORTH
DOT_死亡密度_NORTH
DOT_NORTH
健保北區
32VHCA_North14
HW_NAME
HW_N
32VHCA_NORTH_NAME
10KM_N
5KM_N
group3
group4
group5
group6
NEW_AREA
NEW_ER_AREA
ER_A
ER_B
ER_C
2VHW_85
HW_NORTH
DOT_死亡密度368
DOT底圖
健保六大分區原圖
Taiwan e-Map(new)
1死亡密度368
1死亡密度50
DOT
VV0517_368
1
北區健保分區
建議鼓勵三家醫院成
立甲類安寧居家團隊
及建立區域安寧網絡
天主教仁慈醫院
竹北
臺大新竹
臺大醫院新竹分院
新竹
國泰新竹
馬偕新竹
中壢
怡仁附設
聯新附設
20床
敏盛醫院
12床
桃園長庚紀念醫院
臺北榮總桃園分院
桃附設
聖保祿醫院
國軍桃園總醫院
臺北榮總新竹分院
12床
為恭紀念醫院
12床
竹東
中港
衛生福利部苗栗醫院
4床
海線
梓榮附設弘大屋
苗栗
苑裡李綜合醫院

數據推估的四大核心基準

人口

2025年12月底預估戶籍人口。

→

長照

衛福部2025年度「長照推估需求人數」。

→

死亡

全年累積粗死亡率 × 2025年底人口。

→

安寧

關鍵假設：全年死亡者中 **70%** 具備安寧緩和照護需求。

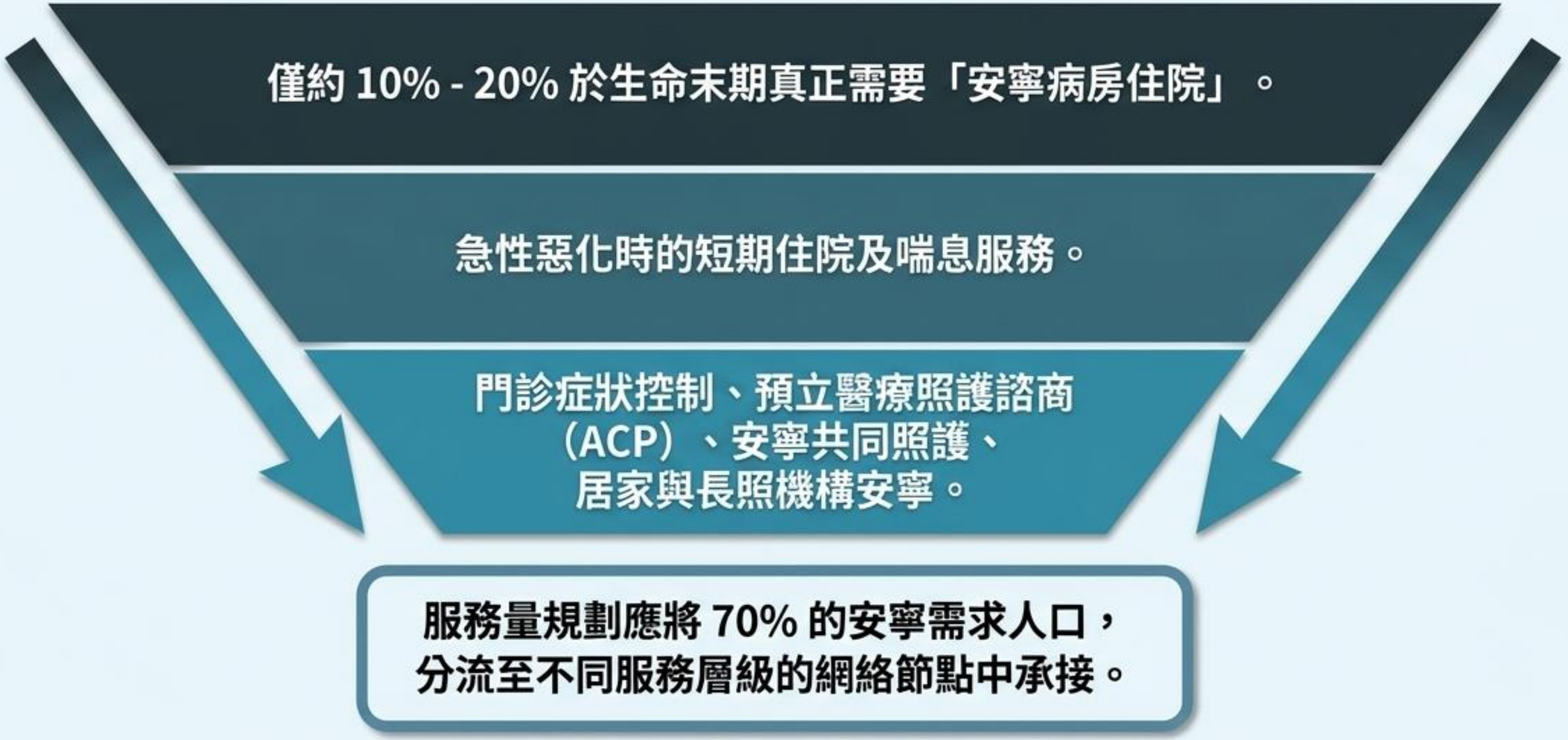
2025 需求推估：人口、死亡與安寧推估總表

地區	2025年底人口	估計全年死亡	每月安寧需求
桃園市	2,355,106	約 16,227	約 947 人
南投縣	467,881	約 5,423	約 316 人
北投+士林區*	493,841	約 3,926	約 229 人
新店區*	306,884	約 2,262	約 132 人
嘉義市	261,592	約 2,229	約 130 人

*標示為區級推估值。註：安寧需求以全年死亡者70%估算。

重新定義：「每日安寧需求」的實務意義

每日安寧需求（如桃園31人、南投10人、嘉義4人）≠ 每天需要增加這麼多安寧病房！



三種區域原型：因地制宜的網絡策略



嘉義模式

醫療中心 / 中型城市

資源相對完整，安寧床位與團隊居全臺前段。

策略：走向網絡整合



南投/埔里模式

資源稀疏區 / 廣大腹地

人均資源尚可，但腹地極廣，交通時間長。

策略：解決地理可近性



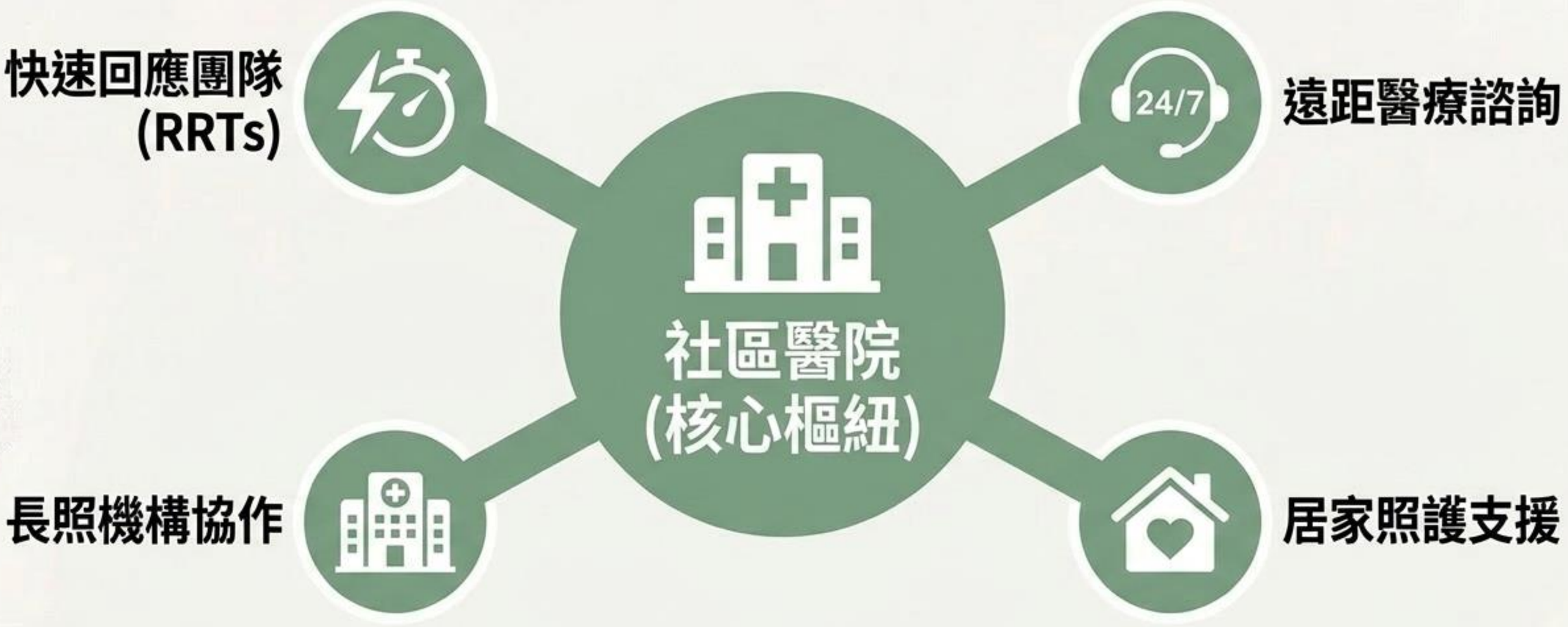
桃園模式

都會區 / 總量龐大

人口成長快，服務密度未跟上需求。

策略：克服服務碎片化

翻轉現況：建構以社區為基礎的安寧網絡



核心原則：結合長照與醫療，減少往返急診的辛勞，最大化資源利用率。

被低估的痛點：失智症末期的照護盲點

The Dementia Blindspot

12.95人 / 每10萬人

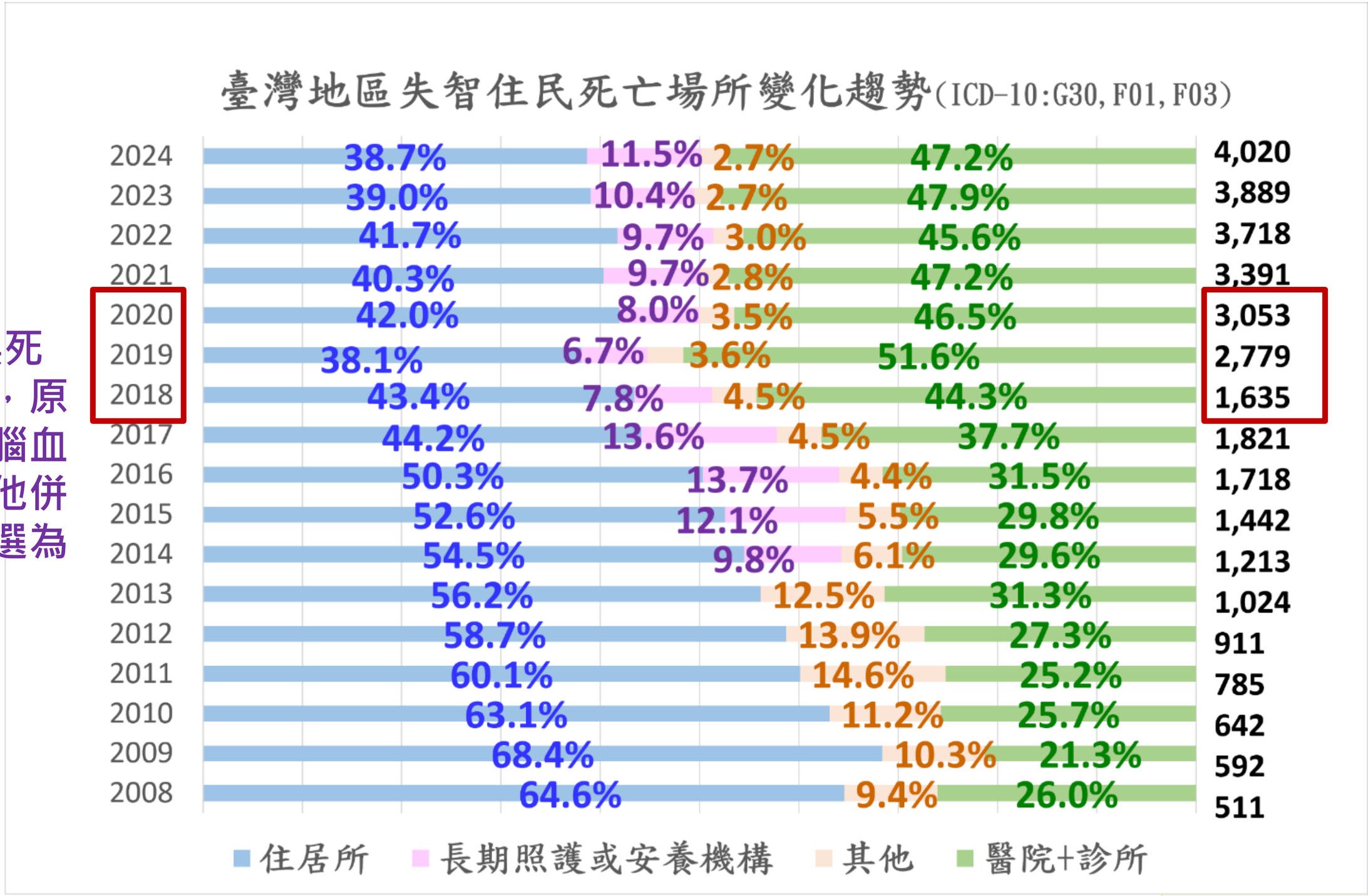
（2020年失智症死亡率，顯著攀升）

- 死因常被低估（易被錯歸類為肺炎）
- 在家死亡率已降至 42.0%
- 機構內死亡率異常偏低（<10%）



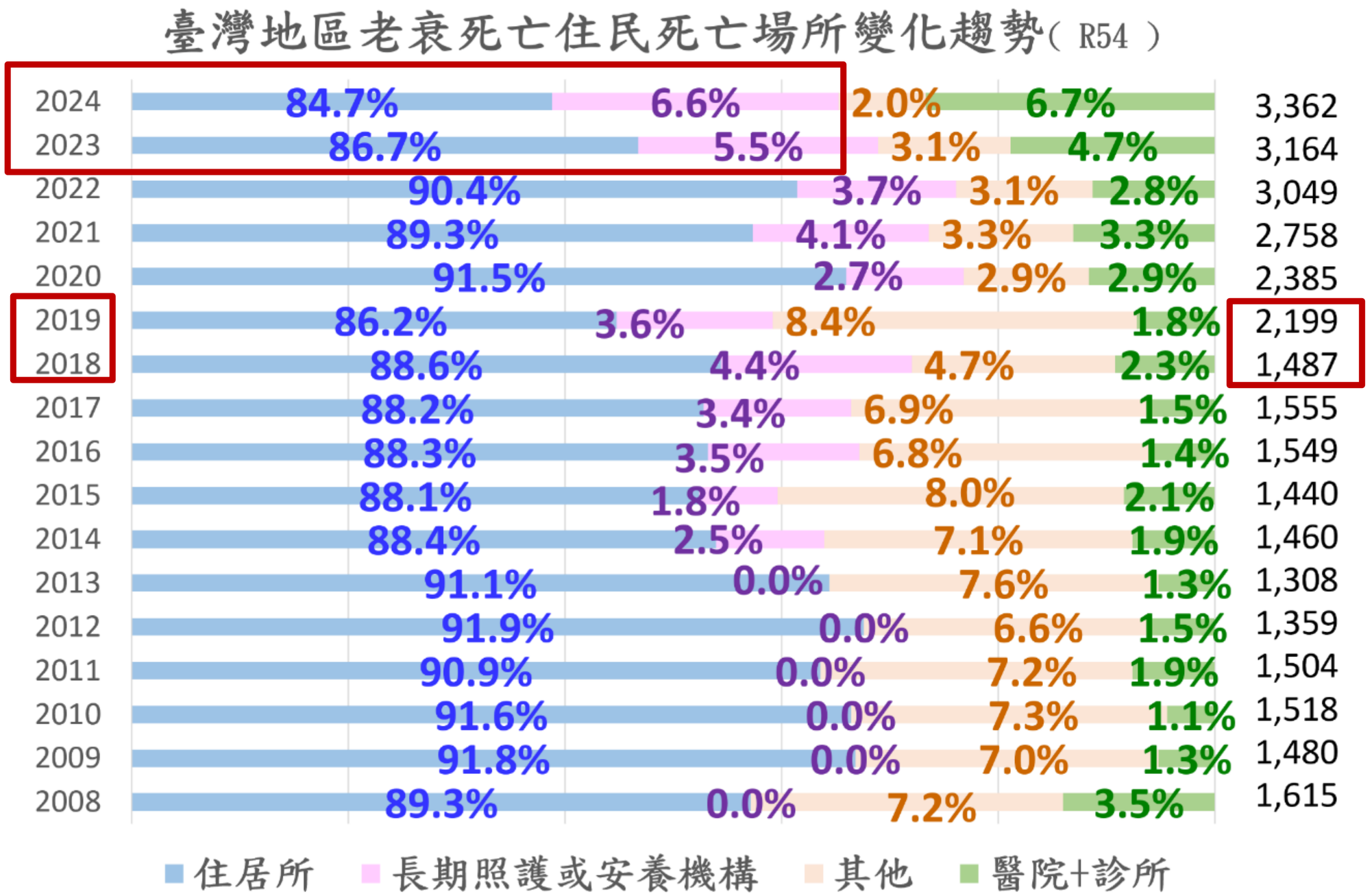
若未正確認列失智症末期照護需求，
政策與資源配置將持續低估這群病人的真實需要。

2019年更換死因選碼系統，原死於肺炎、腦血管疾病或其他併發症者被改選為失智死因。



2022/06，擴大安寧療護對象納入末期衰弱老人

2019年更換死因選碼系統，原其他死因者被改選為老衰死因。



開闢綠色通道：推動急診安寧療護的急迫性



安寧居家團隊多僅於平日白班運作

預講的綠色通道



急診室必須成為接住「預期在醫院過世病人」的最後一道安全網。

善終的指標，是最後30天的照護軌跡



臺灣末期病人的困境不在於死亡那一刻的場所，而在於缺乏能跨越醫院、家庭與長照機構的區域照護責任網。建立依地地區特性量身打造的在地安居網絡，是安寧政策的下一步。

結語：在地安居不是一張病床，是一張承接生命最後旅程的網

1 提早辨識

2 共同照護計畫

3 居家與機構支持

4 24小時緊急應變

5 必要時快速住院

6 回到熟悉地點 持續照護與善終

Palliative for All

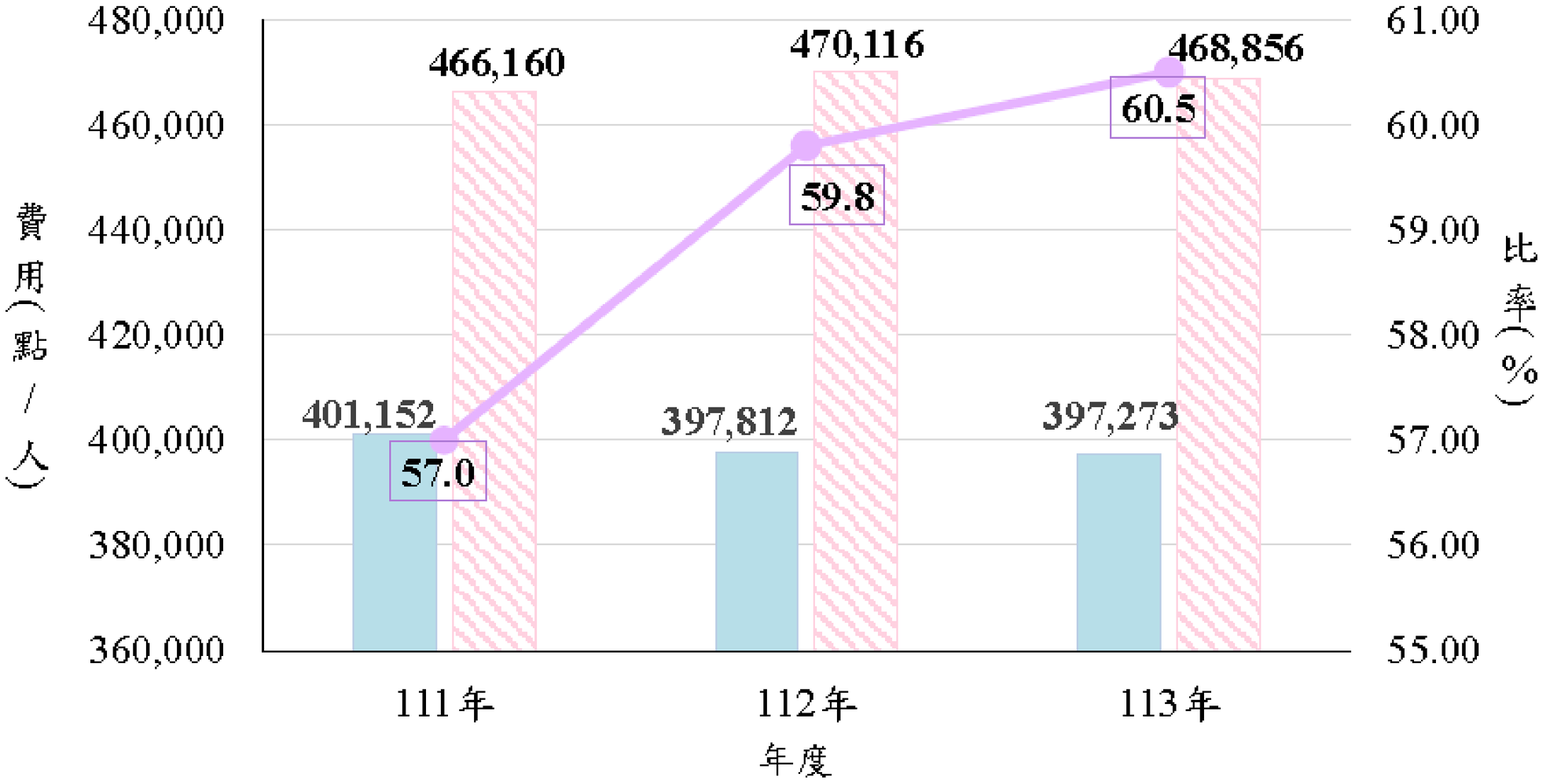
區域共同責任

整合照護的終點，不是完成一次轉介，而是讓每一個人即使走向生命末期，仍能在熟悉的社區中，被持續看見、持續照顧，有尊嚴地安居與善終。

以下為補充資料！！

Ming-Hwai

111~113年因癌症死亡病人死亡前醫療概況



111~113 年因癌症死亡病人死亡前 6 個月醫療概況

死亡年	死前 6 個月已接受安寧療護者			未接受安寧療護者之醫療費用
	安寧費用 (點/人)	非安寧費用 (點/人)	合計 (點/人)	(點/人)
111 年	51,329	349,823	401,152	466,160
112 年	57,434	340,378	397,812	470,116
113 年	50,144	347,128	397,273	468,856

註：死亡前未進行安寧療護者為以死前一年內曾就醫者進行配對，配對方式為性別、十歲年齡組、曾進行安寧者十大死亡原因、有無癌症之變項進行 Propensity Score 配對，樣本數為 1：2。

113 年每人平均醫療費用前 5 項最高之診療類別(排除基本診療)

曾接受安寧療護者		未接受安寧療護者	
項目	點/人	項目	點/人
藥費	128,694	藥費	157,071
診療費	49,842	診療費	63,181
治療處置費	30,164	檢查費	38,397
檢查費	23,457	放射線診療費	24,584
放射線診療費	17,609	治療處置費	24,824

Ming-Hwai

113年全民健康保險監理指標監測結果報告P16

指標**1.3** 癌末病人接受安寧療護比率及生前**6**個月每人申報醫療費用點數

5.健保署提報監測結果：113 年癌末病人死亡前 6 個月有申報安寧照護費用之比率較前 2 年提高 3 個百分點；且死前 6 個月已接受安寧療護者，每人平均醫療費用較未接受安寧療護者減少 71,583 點。

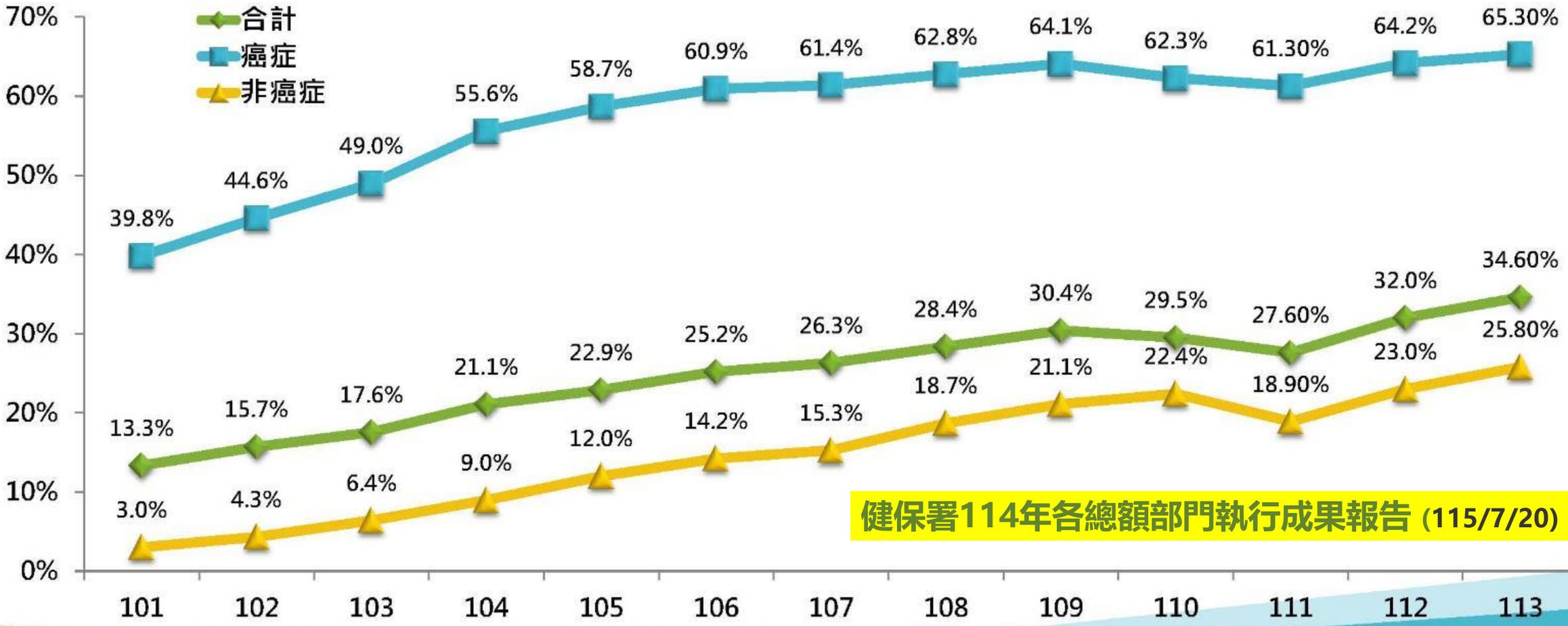
近 3 年癌末病人死亡前 6 個月內有申報安寧照護費用之比率

年度	參考數據		指標結果
	癌症死亡人數(人)(A)	癌症病人死亡前 6 個月內有申報安寧費用者(人)(B)	比率(%)(B/A)
111 年	51,927	29,584	57.0
112 年	53,126	31,788	59.8
113 年	54,032	32,673	60.5

過程面

安寧醫療：病人死亡前1年接受安寧療護之比率

受111年擴大安寧療護收案對象影響，死前1年接受安寧療護比率略有下降；112年-113年呈上升趨勢



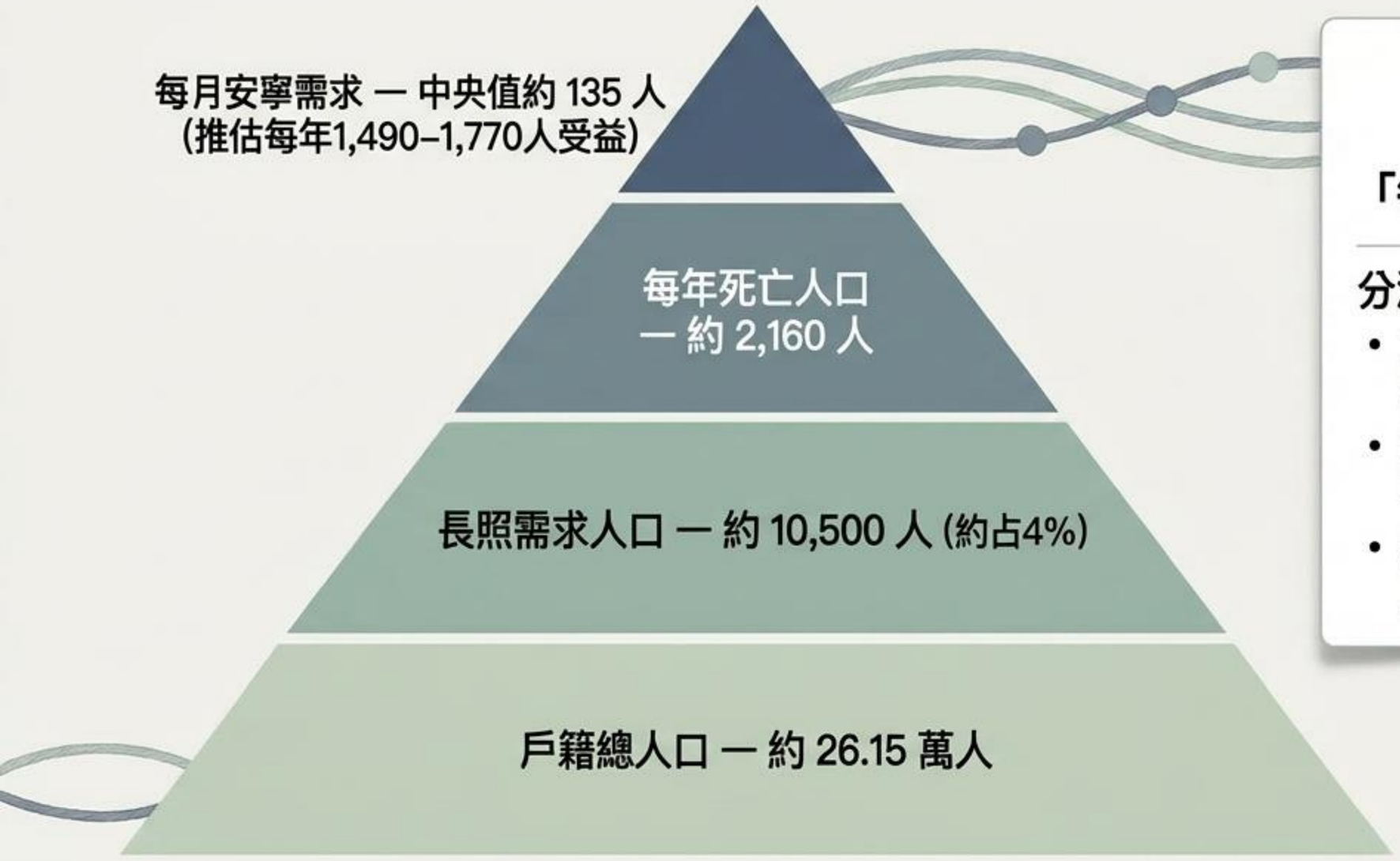
健保署114年各總額部門執行成果報告 (115/7/20)

註：非癌症於111年新增末期骨髓增生不良症候群(MDS)、末期衰弱病人、病人自主權利法、罕見疾病或其他預估生病受限者。

在地安居照護網藍圖：一網、兩軸、三層、四項保證



嘉義市需求推估：將人口數轉換為照護責任



「每月135人需要安寧」
≠
「每月需要135張安寧病床」

分流策略：

- 多數：基層醫療與長照團隊提供基本緩和。
- 部分：安寧共照或居家安寧專業介入。
- 少數（複雜/崩潰/急性）：進入住院安寧。

嘉義模式：從「資源存在」走向「跨體系整合」



核心策略：打通行政與體系壁壘

1. 建立單一高風險辨識機制與跨院共同照護計畫
2. 出院後 72 小時強制接續機制
3. 確保 24 小時諮詢與住宿機構安寧支援
4. 突破行政界線：嘉義市與嘉義縣的跨區合作網絡

挑戰不在於「建置新病床」，而是「打造照護資訊與責任的連續體」。

嘉義市五年推動路徑：從共識到結果



NotebookLM